

수검자 정보

성명: 최수빈 성별/생년월일: 여 / 1974.09.30 나이: 만 51세
기저질환: 고혈압, 당뇨병, 부정맥 검진일: 2026.07.09 문서번호: VHC-20260709-CSB-004

혈압

139/90 mmHg

고혈압 관리 필요

혈당

135 mg/dL

상승 - 재검/관리 권고

BMI

30.4

비만

체지방률

42.1 %

높음

골격근량

20.1 kg

근감소 위험 점검

심박

72 bpm

평균 정상 / 부정맥 이력

항목	측정값	판정	의미 및 확인사항
심박	72 bpm	안정 시 정상 범위	주의: 간헐적 spike 관찰
혈당	135 mg/dL	상승	당뇨병 병력 고려, 식후/공복 여부 확인 필요
혈압	139/90 mmHg	고혈압 관리 필요	이완기혈압 90으로 조절 미흡 가능
몸무게	76 kg	체중 관리 필요	BMI와 체지방률 함께 평가
BMI	30.4	비만	대사질환 위험 증가 가능
골격근량	20.1 kg	낮은 편	근력 운동 및 단백질 섭취 점검
체지방률	42.1 %	높음	복부비만/대사증후군 평가 권고

종합 판정

혈압 139/90 mmHg, 혈당 135 mg/dL, BMI 30.4, 체지방률 42.1%로 확인되어 고혈압 및 당뇨병 병력 관리, 비만 및 체지방 증가에 대한 생활습관 개선이 필요합니다. 부정맥 병력이 있으므로 심박 그래프의 일시적 상승 구간은 증상 동반 여부를 확인하고 필요 시 심전도 검사를 권고합니다.

진단 요약

구분	가상 진단명	근거	관리 수준
1	고혈압 조절 미흡 의심	현재 혈압 139/90 mmHg 및 기존 고혈압 병력	주의/추적
2	당뇨병 또는 혈당 조절 불량 가능	혈당 135 mg/dL 및 당뇨병 병력. 공복/식후 여부 확인 필요	주의/재검
3	비만 및 체지방 과다	BMI 30.4, 체지방률 42.1%	관리 필요
4	부정맥 병력 - 심전도 확인 권고	부정맥 태그와 심박 그래프상 일시적 상승 구간	전문의 상담

의사 소견 - 가상

- 현재 수치는 고혈압, 당뇨병, 비만이 함께 존재하는 대사성 위험군에 해당하는 양상입니다.
- 혈압은 수축기 139, 이완기 90으로 생활습관 개선과 약물 순응도 확인이 필요합니다. 가정혈압을 아침/저녁으로 1-2주 기록하여 평균값을 확인하는 것이 좋습니다.
- 혈당 135 mg/dL은 측정 조건에 따라 해석이 달라질 수 있으므로 공복혈당, 식후 2시간 혈당, HbA1c 검사를 통해 조절 상태를 재평가해야 합니다.
- BMI 30.4와 체지방률 42.1%는 체중 감량 및 근육량 유지가 필요한 수준입니다. 무리한 감량보다 주 150분 이상 유산소 운동과 주 2-3회 근력운동을 병행하는 것을 권장합니다.
- 부정맥 병력이 있으므로 두근거림, 흉통, 어지러움, 실신감이 있거나 심박 이상이 반복되면 심전도 및 24시간 홀터 검사를 고려합니다.

권고 검사 및 추적관리

항목	권고 내용
혈압	가정혈압 1-2주 기록, 염분 섭취 조절, 약물 복용 여부 확인
혈당	공복혈당, HbA1c, 신장기능, 소변 미세알부민 검사
심혈관	지질검사, 심전도, 필요 시 홀터검사
비만/체성분	허리둘레, 간기능, 체성분 추적, 운동 처방 상담

중요 안내

아래 처방은 데이터 기반 시뮬레이션을 위한 가상 예시입니다. 실제 복용, 조제, 보험청구, 의료기관 제출에 사용할 수 없습니다. 실제 약물은 의사의 진료와 검사 결과에 따라 결정되어야 합니다.

수진자 및 처방 정보

성명	최수빈	성별/생년월일	여 / 1974.09.30
처방일	2026.07.09	진단 참고	고혈압, 당뇨병, 부정맥
의료기관	헬스업 가상의원	담당의	AI 가상 주치의

가상 처방 내역

분류	가상 처방 예시	용법	기간	비고
혈압관리	ARB 계열 혈압약 예시	1일 1회	14일	실제 약제/용량은 진료 후 결정
혈당관리	Metformin 계열 혈당강하제 예시	식후 1일 1-2회	14일	신장기능 확인 후 판단
심혈관 위험관리	지질검사 결과에 따른 스타틴 고려	의사 판단	-	검사 결과 필요
부정맥 평가	약물 처방 전 심전도/홀터검사 우선 권고	검사 의뢰	-	증상 동반 시 신속 진료

생활 처방

영역	권고 내용
식이	나트륨 섭취 줄이기, 단순당/음료 제한, 식이섬유와 단백질 충분히 섭취
운동	빠르게 걷기 등 유산소 운동 주 150분 이상, 근력운동 주 2-3회. 부정맥 증상 시 운동 중단
모니터링	혈압은 아침/저녁, 혈당은 의료진 지시에 따라 기록. 두근거림/흉통/어지러움 발생 시 진료
추적진료	2-4주 내 내과 또는 가정의학과 재상담, 당화혈색소와 심전도 검사 권고